

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΚΑ

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Αναστολείς Μετατρεπτικού Ενζύμου | 5. Ανταγωνιστές Αλδοστερόνης |
| 2. Αποκλειστές Υποδοχέων Αγγειοτασίνης II | 6. Β - Αναστολείς |
| 3. Διουρητικά (θειαζιδικά και άλλα) | 7. Δακτυλίτιδα |
| 4. Συνδυασμός ΑΜΕΑ ή ΑΥΑ με διουρητικό | 8. Αναστολείς SGLT-2 |

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (α-MEA)

Η χορήγηση των α-MEA είναι ιδιαίτερος ωφέλιμη στη θεραπεία της ΧΚΑ, ανεξαρτήτως εάν συνυπάρχει αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) ή όχι. Και αυτό προκύπτει διότι:

- Προκαλούν αγγειοδιαστολή και μειώνουν το καρδιακό προ- και μεταφορτίο.
- Μειώνουν τις συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις.
- Μειώνουν την σκλήρυνση της αορτής.
- Βελτιώνουν το ενεργειακό ισοζύγιο του μυοκαρδίου.

Η χρήση τους ενδείκνυται για πρόληψη και θεραπεία σε όλους τους ασθενείς με ΧΚΑ με κλάσμα εξώθησης (LVEF) < 40%, ακόμη και στους ασυμπτωματικούς. Επίσης, σε ασθενείς με ΧΚΑ ανεξαρτήτως κλάσματος εξώθησης με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Οι α-MEA έχουν επίσης ένδειξη για τις εξής κατηγορίες ασθενών:

- Ασθενείς υπερτασικοί, με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.
- Ασθενείς με ΑΥ και ιστορικό ΣΔ τύπου 2.
- Ασθενείς με ΑΥ και χρόνια νεφρική νόσο ($eGFR < 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$).
- Ασθενείς με ΑΥ, ηλικίας > 65 ετών.

Αρχικώς, χορηγείται μικρή δόση α-MEA και εφόσον γίνει καλά ανεκτή τότε επιχειρείται διπλασιασμός της δόσεως, κάθε 2 εβδομάδες, μέχρι την επιθυμητή ή τη μέγιστη δόση.

Η μακρά διάρκεια δράσης, ορισμένων εξ αυτών, θεωρείται πλεονεκτική και ζητούμενη, επειδή επιτρέπει τη χορήγησή τους μια φορά την ημέρα (*qd*), αλλά αποτελεί και ιδιότητα που θεωρείται ιδιαίτερος ευεργετική σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

ΟΥΣΙΑ	ΣΚΕΥΑΣΜΑ	Ημερήσια δόση	t _{max}	Χρόνος Ημιζωής
Βεναζεπρίλη	<i>Cibacen</i>	5-20 mg	1,5 h	10 h
Εναλαπρίλη	<i>Renitec / Analept</i>	10-20 mg	6-12 h	11 h
Ζοφενοπρίλη	<i>Zofepril / Zopranol</i>	7,5-30 mg	2-7 h	6 h
Καπτοπρίλη	<i>Normolose</i>	50-200 mg	3-5 h	3 h
Κιναπρίλη	<i>Accupron</i>	20-40 mg	1,5-3 h	26 h
Λισινοπρίλη	<i>Zestril / Z-Bec</i>	10-20 mg	1-2 h	24 h
Περινδοπρίλη	<i>Coversyl</i>	4-8 mg	0,5-1 h	9 h
Ραμιπρίλη	<i>Triatec / Piramil</i>	5-10 mg	0,5-2 h	15 h
Σιλαξαπρίλη	<i>Vascase</i>	2,5-5 mg	1 h	40 h
Τραντολαπρίλη	<i>Testolan</i>	0,5-4 mg	6 h	10 h
Φοσινοπρίλη	<i>Monopril</i>	20-40 mg	3 h	12 h

Για να αποφευχθεί η υπερκαλιαιμία, θα πρέπει πριν αρχίσει η χορήγηση ενός α-MEA να διακοπεί η χορήγηση διουρητικών προστατευτικών της απώλειας καλίου, καθώς και των σκευασμάτων υποκατάστασης καλίου (Sopa-K). Η έναρξη χορήγησης α-MEA σε ασθενείς με ΧΚΑ που ήδη λαμβάνουν υψηλές δόσεις διουρητικών της αγκύλης (*Φουροσεμίδα 80 mg ή Τορασεμίδα 10 mg ημερησίως*) είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρή υπόταση.